Insulina: zonas y rotación

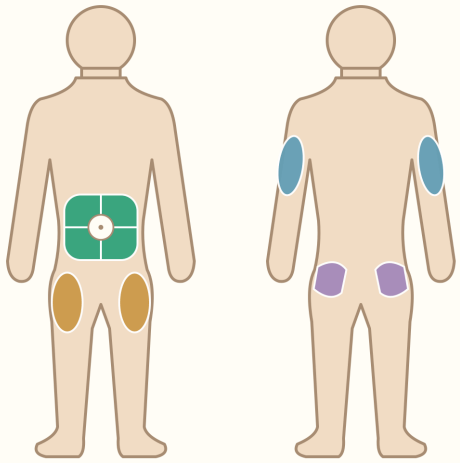
Mapa corporal · basal y basal-bolo

Rotar significa cambiar el punto de cada pinchazo de forma ordenada. El objetivo es proteger la piel y mantener una absorción de insulina más predecible.

ENDONUTRI · EDUCACIÓN DIABETOLÓGICA

Cada pinchazo, en un punto diferente

Zonas de inyección de insulina y rotación sistemática



POR DELANTE POR DETRÁS

1 **Abdomen**
Divide en 4 sectores; evita el ombligo.

2 **Muslos**
Zona anterior y externa del tercio superior.

3 **Brazos**
Zona posterior media de la parte superior.

4 **Glúteos**
Zona superior y externa de cada lado.

Un sector cada semana

1	2
4	3

Avanza siempre en el mismo sentido.
Dentro del sector, separa los puntos **al menos 1 cm.**

Solo basal
Zona sana y accesible; rota los puntos.
No es obligatorio usar muslo o glúteo con todos los análogos basales.

Basal-bolo
Puedes reservar sectores para cada insulina.
Es una ayuda para organizarse, no una regla fija.
Con NPH/regular, mantén región y horario estables.

Piel sana · Aguja nueva · Evitar bultos · Revisar técnica y ficha del medicamento

Esquema orientativo de adultos. Fuentes: FITTER Forward 2025; FIT selección y rotación; recomendaciones FITTER 2016.

Un recorrido fácil de recordar

- Abdomen: divide la zona en cuatro sectores. Usa uno cada semana y avanza siempre en el mismo sentido; separa cada punto al menos 1 cm del anterior. Evita el ombligo y la piel lesionada.
- Muslos: parte anterior y externa del tercio superior. Glúteos: zona superior y externa. Brazos: cara posterior del tercio medio de la parte superior; puede requerir ayuda para una técnica correcta.
- Inspecciona y palpa las zonas. No pinches en bultos, endurecimientos, cicatrices o inflamación. Una zona que duele menos puede tener lipohipertrofia.

Insulina · pauta y técnica

Pauta	Cómo organizarla
Solo basal	Elige una zona accesible y sana; rota dentro de ella. Con glargina o degludec no es obligatorio reservar el muslo o el glúteo: manda la ficha técnica y una técnica consistente.
Basal-bolo	Puedes reservar sectores distintos para basal y rápida para facilitar el registro. Es una ayuda organizativa, no una obligación. Con análogos, las zonas autorizadas no se asignan por una regla universal de lenta/rápida.
NPH o insulina regular humana	La zona puede modificar más la velocidad de absorción. Mantén la misma región para la misma dosis/horario y rota los puntos; individualiza con el equipo.

Técnica que conviene comprobar en consulta

- Aguja de pluma de 4 mm como opción habitual; entrada a 90°. Valora pliegue si hay poco tejido subcutáneo, especialmente en niños o personas muy delgadas.
- Aguja nueva en cada inyección. Comprueba insulina, concentración, dosis y cebado de la pluma según su manual. Mantén el pulsador y espera el tiempo que indique el fabricante.
- No compartas plumas. Desecha las agujas en un contenedor autorizado. Evita masajear la zona.

Al pasar de una zona con lipohipertrofia a piel sana puede aumentar la absorción y aparecer hipoglucemia. Planifica vigilancia y revisión de dosis con el equipo; no apliques una reducción fija a todos los pacientes.

Fuentes

FITTER Forward, recomendaciones 2025 · FIT, selección y rotación de zonas · FITTER 2016, farmacocinética por zonas